

УДК: 616.74-006.6-08-059

Д.Х.Савхатов, Г.А.Серикбаев, Д.А.Тулесуова, Ж.О.Мауленов, Е.Е.Сармурзаев, А.К.Курманалиев
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Результаты комбинированного лечения сарком мягких тканей

Аннотация. Цель работы. Оценить влияние химиотерапии на риск возникновения прогрессирования у больных саркомами мягких тканей.

Проведен анализ данных 50 пациентов с саркомами мягких тканей, получавших лечение в отделении опухолей костей и мягких тканей с 2011 по 2013 годы. Всем пациентам выполнена комбинированная терапия с проведением хирургического этапа лечения. Неоадьювантную ХТ получили 9(18%) пациентов, 8(16%) получили адьювантную ХТ, 4 (7%) пациента- нео- и адьювантную ХТ, 29 (58%) пациентам, у которых опухоль не более 5см в диаметре химиотерапия не проводилась.

Частота прогрессирования в группе пациентов с наличием опухоли более 5 см с наличием некроза и кровоизлияний после первого курса неоадьювантную химиотерапию составила 5/6(83%), при проведении 2 - 3 курса неоадьювантной химиотерапии прогрессирование наступало у 4/11 (36%) пациентов, а у пациентов операция+ адьювантная химиотерапия 2-3 курса, локальный рецидив отмечен у 2/8(25%) больных. При отсутствии ХТ прогрессирование отмечено у 14/25(56%) пациентов.

С целью снижения риска рецидива сарком мягких тканей пациентам следует назначать адьювантную химиотерапию.

Ключевые слова: саркомы мягких тканей, химиотерапия, рецидив

Введение

Саркома мягких тканей (СМТ) составляют 0,5 – 2% всех злокачественных опухолей человека, интенсивный показатель которого составляет 1,7 случая на 100 000 населения (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2007). Чаще всего локализуется в мягких тканях конечностей, туловища, на много реже в забрюшинном пространстве. Выделяют более 30 подтипов сарком мягких тканей. Прогноз у взрослых больных зависит от ряда факторов, включающих возраст пациента, размер, степень злокачественности, локализация опухоли и стадию заболевания. При опухолях с низкой степенью злокачественности и не более 5 см в диаметре чаще всего проводится хирургическое лечение. Ряд авторов отмечают, что при саркомах с высокой степенью злокачественности, определяемому по митотическому индексу, наличию кровоизлияний и некрозов, чаще развиваются рецидивы и отдаленные метастазы. В связи с чем больным с данным типом опухоли требуется комбинированный подход в лечении. По данным метанализа адьювантная химиотерапия, включавшая препарат доксорубин, уменьшает риск возникновения рецидива на 44% (Pervaiz N. et al., 2008). Нами была предпринята попытка оценить влияние адьювантной и неоадьювантной химиотерапии на риск возникновения прогрессирования у больных местнораспространенными

саркомами мягких тканей.

Цель работы

Оценить влияние химиотерапии на риск возникновения прогрессирования у больных различных подтипов сарком мягких тканей.

Материал и методы

Проведен анализ историй болезни 50 больных с первичными саркомами мягких тканей. Лечение проводилось в отделение опухолей костей и мягких тканей Казахского НИИ онкологии и радиологии в период с 2011 г. по 2013 г. Характеристика больных представлена в таблице.

Таблица - Характеристика пациентов

Признак	N=50 (100%)
Возраст (медиана лет)	47 (min 24 – max 70)
Пол	
Муж	22 (46%)
Жен	28 (56%)
T	
1a	1 (2%)
1b	7 (14%)
2a	3(6%)
2b	39(78%)
N	
0	48 (96%)
1	1 (2%)
X	1 (2%)
M	
0	50 (100%)
G	
2	15 (30%)
3	34 (68%)
X	1 (2%)
Стадия	
11a	8(16%)
11b	7 (14%)
111	35 (70%)
Размер опухоли (медиана в см)	15 (min 5-max 25)
Вид операции	
Фасциально-фулярное удаление опухоли	48 (96%)
ампутация	2 (4%)
Локализация опухоли	
Верхняя конечность	12 (24%)
Нижняя конечность	29 (58%)
туловище	9 (18%)
Неоадьювантная ХТ	9 (18%)
Схема химиотерапии – доксорубин по 75мг/м2	21 (42%)

Количество курсов неoadьювантной ХТ	3,5 (min 1-max 6)
Эффект неoadьювантной ХТ	
Стабилизация	5 (55%)
Частичный эффект	4 (45%)
Адьювантная ХТ	8(16%)
Количество курсов адьювантной ХТ	4 (min 2 – max 6)
Без химиотерапии	29 (58%)
Неoadьювантная ХТ +адьювантная ХТ	4(8%)

Всем пациентам было выполнено радикальное хирургическое лечение в объеме фасциально-фуллярного удаления опухоли с проведением нео- и адьювантной химиотерапии. Медиана наблюдения за больным составила 20 месяцев. Прогрессированием считалось возникновение рецидива и/или появление метастазов.

Результаты. Проведен сравнительный анализ характеристик больных с СМТ. В группе со злокачественная фиброзная гистиоцитома (ЗФГ) чаще встречались опухоли высокой степени злокачественности (G3) у 6/13(46%), в группе остальных сарком мягких тканей G2-G3 у 16/37 (43%). 111 стадия опухолевого процесса в группе больных со ЗФГ отмечена у 7/13 (53%), во всей группе саркомы мягких тканей (СМТ) у 13/37 (35%). В группе больных со ЗФГ(13) местный рецидив возник у 4/13(31%), в группе с СМТ у 12/37(32%).

В группе больных со ЗФГ, не получавших ни один вид химиотерапии, единственным неблагоприятным признаком, влияющих на прогрессирование, явилось размер опухоли (Т) и наличие некроза и кровоизлияния. С увеличением объема опухоли с наличием некроза и кровоизлияния пропорционально отмечалось прогрессирование опухолевого процесса с появлением регионарных метастазов. При сравнении больных, получавших неoadьювантную + адьювантную ХТ и только адьювантную ХТ, с группой больных, не получавших ХТ, оказалось, что данные группы между собой по основным характеристикам достоверно не различаются. А также не наблюдалось различий по основным характеристикам в группе больных, получавших неoadьювантную ХТ и больных, находившихся под наблюдением. На основании выше указанных данных больные были разделены на « группы:

- больные получавшие адьювантную ХТ (или нео- + адьювантная ХТ)
- больные получавшие только неoadьювантную ХТ или находившиеся под наблюдением).

В группе больных, не получавших адьювантную ХТ, прогрессирование отмечено у 5/9 (55%), в группе больных, получавших адьювантную ХТ, - у 3/8 (37%).

Обсуждение

По данным различных авторов, химиотерапию больным с СМТ следует проводить с наихудшим прогнозом (высокая степень злокачественности, распад и кровоизлияния). Пациентам с благоприятным прогнозом рекомендуется только оперативное лечение. Отсутствуют исследования, где всем пациентам с опухолью более 5 см было бы назначено лекарственное лечение. Следовательно, делать выводы об эффективности неoadьювантной и адьювантной ХТ при СМТ затруднительно. По нашим данным на небольшом количестве больных (17 человек) со ЗФГ получены следующие данные: при проведении предоперационной ХТ, прогрессирование возникло чаще, чем проведение ХТ в адьювантном режиме. Адьювантную ХТ желательно проводить с резектабельными формами ЗФГ в не

зависимости от наличия или отсутствия неoadьювантной химиотерапии.

Список литературы

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2007 г. //Вестник онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина РАМН. - М., 2009. - Т.20(3)
2. Алиев М.Д. Современные подходы к лечению сарком мягких тканей // Практическая онкология. - 2004 - Т.5, №4.
- Pervaiz N., Colterjohn M. et al. A Systematic Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials of Adjuvant Chemotherapy for Localized Resectable Soft-Tissue Sarcoma //Cancer. - 2008. - V. 113.

Тужырым

Д.Х.Савхатов, Г.А.Серикбаев, Д.А.Тулеуова,
Ж.О.Мауленов, Е.Е.Сармурзаев, А.К.Курманалиев
Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ
Жұмсақ тін саркомасының комбинирленген емнің қорытындысы

Сүйек және жұмсақ тіндер саркомасы емделетін бөлімшеде емделген 50 науқасқа сараптама жасалынды. Науқастың барлығы үйлестіру әдісімен емделді. Науқастар ісік көлеміне және қатерлі ісік дәрежесіне байланысты операция алдында және операциядан кейін химия дәрі-дәрмек емін қабылдады. Талдау нәтижесінде химиядәрісін операция алдында алған науқастарда қатерлі ісіктің ары-қарай өсуі көбірек байқалды, ал керісінше, химиялық дәріні операциядан кейін алғандарда ісіктің ары-қарай өсуі кемірек болды.

Түйінді сөздер: жұмсақ тіндер саркомасы, химиотерапия, озықтық, рецидив

Summary

D.H.Savkhatov, G.A.Serikbaev, D.A.Tuleuova,
Zh.O.Maulenov, E.E.Sarmurzaev, A.K.Kurmanaliev
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Results of combined treatment of soft tissue sarcomas
Aim: To estimate the influence of chemotherapy on risk of emergence of progression in sarcomas of soft tissue

The analysis of the data of 50 patients with soft tissue sarcomas treated in the department of bone tumors, soft tissue and melanomas from 2011 by 2013 were carried out. All patients had combined treatment with surgical treatment phase. 9 Patients (18%) had Neoadjuvant chemotherapy, 8 patients (16%) had adjuvant chemotherapy, 7% of the patients (4) got neoadjuvant and adjuvant chemotherapy, 29 patients (58%), whose tumors no larger than 5 cm in diameter, did not have any chemotherapy.

The frequency of progression in group of patients, who have tumors more than 5 cm with necrosis and hemorrhage after the first course of neoadjuvant chemotherapy, were 83% (5/6), during the 2-3 courses of neoadjuvant chemotherapy progression occurred in 4/11 (36%) of patients and local recurrence was observed in 2/8 (25%) patients receiving surgical treatment: 2-3 courses of adjuvant chemotherapy. In the absence of chemotherapy progression was noticed in 14/25 (56%) patients.

In order to reduce the risk of recurrence of soft tissue sarcoma, patients should be prescribed adjuvant chemotherapy.

Keywords: soft tissue sarcomas, chemotherapy, progression, recurrence.